Resumos de Pediatria



Batistaz

Revisão Flash · Respiratório

Pneumonia Adquirida na Comunidade

Da taquipneia ao empiema

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Pneumonia adquirida na comunidade

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Diagnóstico clínico pela taquipneia e pelo esforço; sem exames de rotina na criança que trata em casa; amoxicilina 50 mg/kg/dia por 7 dias; sem melhora em 48–72 h, reavaliar adesão, diagnóstico, agente e complicações, sobretudo derrame.

1 **Taquipneia (AIDPI):** ≥ 50 de 2 a < 12 meses; ≥ 40 de 1 a < 5 anos. < 2 meses com FR ≥ 60: grave (SBP).

2 **Grave (AIDPI):** perigo, tiragem subcostal, estridor em repouso: 1ª dose e referir.

3 **Internar (SBP):** SatO2 < 92%, desidratação, toxemia, apneia, FR > 70 (< 12 m) ou > 50, complicação.

4 **Exames:** nenhum de rotina na PAC ambulatorial com evolução habitual; investigar se má resposta ou febre prolongada. Hemocultura em quem interna. Antígeno urinário, nunca.

5 **Casa:** amoxicilina 50 mg/kg/dia (8/8 ou 12/12 h), máx. 4 g, 7 dias. Macrolídeo só se atípico.

6 **Hospital:** ampicilina 50 mg/kg/dose 6/6 h ou penicilina cristalina 150.000 UI/kg/dia. < 2 m: + gentamicina.

7 **Derrame:** ultrassom; pequeno observa; grande ou pus: drenar; empiema: dreno fino + fibrinolítico.

8 **Necrose:** PAC grave sem melhora em 72 h; TC com contraste; vancomicina + cefalosporina 3–4 semanas.

Duração da amoxicilina

Fonte	Esquema
MS e SBP	50 mg/kg/dia, 7 dias
OMS 2024	40 mg/kg/dose 12/12 h, 5 dias (3 se HIV pouco prevalente)
NICE 2025	3 dias (3 m–11 anos, não grave)

Pegadinha

Abaixo de 2 meses, cefotaxima e não ceftriaxona: a ceftriaxona desloca a bilirrubina da albumina.

Checklist antes do plantão

- ☐ Conto a FR em 1 minuto e sei os cortes
- ☐ Classifico pelo AIDPI e sei quando internar
- ☐ Sei que exames não pedir
- ☐ Prescrevo amoxicilina em mg/kg/dia
- ☐ Sei quando dar macrolídeo
- ☐ Investigo a falha antes de trocar
- ☐ Prescrevo ampicilina em mg/kg/dose
- ☐ Sei quando drenar o derrame
- ☐ Reconheço necrose e abscesso na TC